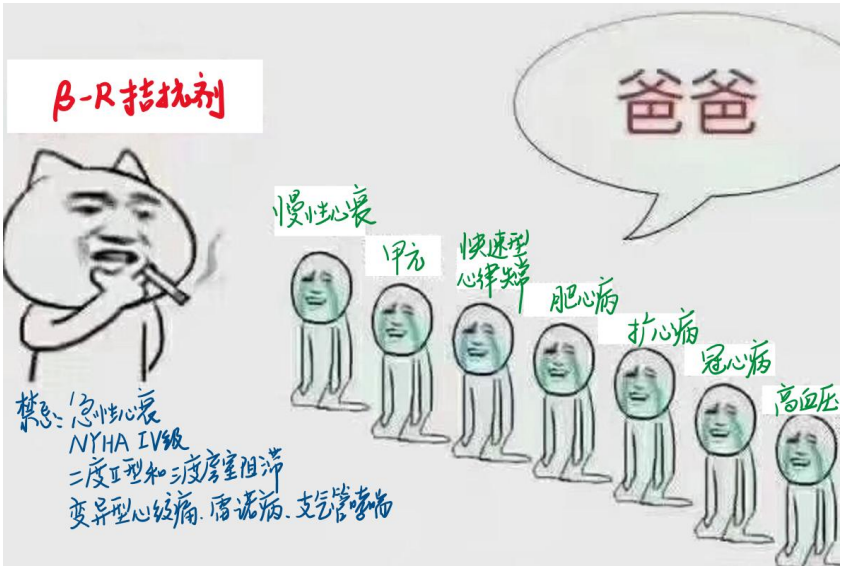
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

	用	不用
ACEI ARB ARNI （普利/沙坦/ 沙库巴曲缬沙坦）	糖尿病、蛋白尿 痛风（ARB） 慢性心衰、扩心病、冠心病、高血压 原则是抗重构(RAAS系统导致重构) ①拮抗交感 ②抑制T4→T3(甲亢时T3活性更高)	①均不用：血Cr＞265、高血钾（＞5.5）、双肾动脉狭窄、妊娠、低血压（机甲吓人地） ②不用ACEI：血管性水肿、不耐受干咳、痛风 ③不要将它们合用 ①药物蓄积 ②高钾血症 ③残存肾单位不能再休息 缓激肽蓄积 增加血管通透性 不能再负性肌力　心功能非常差
β-R拮抗剂 （洛尔） β1-R拮抗剂对 β2-R一样有作用	甲亢、快速型心律失常、肥心病BBBB 慢性心衰、扩心病、冠心病、高血压 必须保持体重恒定（水肿不是禁忌症） 伴明显肾功能不全用卡维地洛阻断β、α β-R拮抗剂的不良反应会放大	急性心衰、NYHA IV级　严重的缓慢型心律失常 病态窦房结综合征、二度II型和三度房室传导阻滞、预激综合征伴房颤 小路 正常 β-R拮抗剂 支气管哮喘、变异型心绞痛、雷诺病 （2234 都积极笑、变异咯）
CCB （维拉帕米是 β的小跟班）	支气管哮喘、变异型心绞痛、雷诺病 痛风 快速型心律失常（维）、肥心病（维）、冠心病、高血压	收缩性心衰 CCB有负性肌力作用,也无法抗重构 病态窦房结综合征、二度II型和三度房室传导阻滞、预激综合征伴房颤 前列腺肥大（223 都说鸡大）膀胱平滑肌不能收缩
利尿剂 先用利尿剂消肿降压， 后用ACEI/ARB或CCB	心衰、高血压（多用于1、2级） 急性肾衰 容量依赖型高血压先利尿消肿降压 若伴低血钠用托伐普坦　对排钠影响不大 主要排水 肾功能很差 当GFR＜30用呋塞米 合用排钾与保钾利尿剂（螺内酯/依普利酮/阿米洛利/氨苯蝶啶）	急性右室梗死水泵变水管 此时需要补液,把血压到左心 痛风不用氢氯噻嗪 血脂增高 伴高血脂吲达帕胺比氢氯噻嗪好 假设一个题目有高血脂,看到就选吲达帕胺 ✗ 他汀类药物才降血脂 前提是当要选利尿剂时出现高血脂,尽量吲达帕胺



思维导图・原发性高血压

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄